Tribunal de Justiça de Pernambuco

Poder Judiciário
2ª Vara Cível da Comarca de Petrolina
PÇ SANTOS DUMMONT, S/N, Fórum Dr. Manoel Souza Filho, Centro, PETROLINA - PE - CEP: 56302-000 - F:(87) 38669519

Processo nº 0006860-56.2021.8.17.3130
AUTOR: J. P. S. C. R., MARIA POLIANA DE SOUZA SILVA.
REU: UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

Vistos, etc...

JOÃO PEDRO SOUZA CANÁRIO RIBEIRO, menor impúbere, neste ato representado por sua genitora, **MARIA POLIANA DE SOUZA SILVA**, através de advogado regularmente constituído, ajuizou a presente **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS** em face de **UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA**, alegando que foi submetido a auxílio profissional objetivando o diagnóstico e o consequente tratamento ao quadro clínico apresentado, tendo sido diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID 10: F84), consoante se infere do relatório médico de lavra da especialista Dra. Rita Lucena, neurologista infantil (CRM 9568), laudo médico (id 84184750).

A autora aduziu, que necessita submeter-se a realização de tratamento médico multidisciplinar a ser realizado de forma ininterrupta, com auxílio de profissionais especialistas prescritos em seu favor, devendo tais profissionais serem portadores da qualificação no modelo Acompanhamento fonoterápico (capacitação em motricidade oral, PROMPT nível 2 e ABA): duas sessões semanais para ampliar a função comunicativa nos aspectos pragmáticos, verbais e não-verbais. Fonoaudiologia para Terapia Neuroacústica (SENA): dois ciclos de dez dias com intervalo de seis meses para favorecer adequação dos elementos envolvidos no processamento auditivo Acompanhamento psicológico (duas sessões semanais de supervisão ABA) para favorecer as habilidades simbólicas e ampliar recursos de teoria da mente. Acompanhamento com terapeuta ocupacional (capacitação em Integração Sensorial: duas sessões semanais de uma hora cada) para promover redução das manifestações do transtorno de processamento sensorial e estimular as habilidades práxicas finas e amplas. Intervenção intensiva baseada em Análise do Comportamento Aplicada (ABA) trinta horas semanais, em ações integradas com outras crianças e mediada em contexto interdisciplinar por assistente terapêutico (AT), dentre outros profissionais.

Ademais, diz que buscou autorização para o tratamento junto a rede credenciada da operadora, entretanto, foi informada, que o plano não cobria as terapias sob o fundamento de que os tratamentos indicados não estão inclusos na tabela de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar (RN nº 428 de 07 de novembro de 2017).

Na esteira dos fatos narrados, requereu: a) a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a demandada, seja compelida a autorizar e custear, integralmente, os tratamentos prescritos, sob pena de multa; b) a condenação da parte requerida em danos morais no importe de R$ 10.000,00.

A decisão (id 97385181) concedeu a tutela provisória.

A parte acionada apresentou contestação (id 105986203), arguindo, em síntese, a falta de cobertura em razão da taxatividade do rol da ANS, a regularidade e os limites contratuais e a inexistência de dano moral. Ao final, pugnou pela improcedência da ação.

A demandada requereu produção de prova pericial (id 115962211).

A decisão (id 133360791) inverteu o ônus da prova, determinou a produção de prova pericial.

O laudo médico pericial foi acostado (ids. 163147633 e 163147635).

As partes se manifestaram (ids. 164539745 e 165875424).

O Ministério Público, manifestou-se (id 189874322), opinando pela total procedência dos pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução de mérito, a fim de que o plano de saúde demandado seja compelido a fornecer os tratamentos médicos pleiteados, conforme Laudo Médico mais atualizado e condenar a demandada em danos morais.

É o breve relatório. Passo ao julgamento.

II – FUNDAMENTAÇÃO

II. 1 – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra o processo, na modalidade de julgamento antecipado do mérito (art. 355, inciso I do CPC), verificando tratar-se que a questão de mérito cinge-se tão-somente à discussão do direito aplicável. Nesse sentido: "*Verificando-se que o feito não necessitava de outras diligências para chegar ao seu fim, mas, ao contrário, conclamava efetiva resolução, nos moldes do art. 330 do Diploma Processual Civil, não há que se falar em cerceamento de defesa. Ademais, a jurisprudência já consolidou entendimento de que se confrontando o Juiz com situações que se enquadram na hipótese do art. 330, do CPC, tal não confere propriamente faculdade ao magistrado, mas, sim, dever de bem e rapidamente ofertar a prestação jurisdicional, velando pela rápida solução do litígio*" (TJDFT – Apelação Cível nº 2002075008274-3 – 3ª Turma Cível – Rel. Des. Jeronymo de Souza).

Do acórdão supra, destaco o seguinte extrato, *verbis*: "*É de ver-se que cogitando o Juiz ser o caso de julgamento antecipado da lide por compreender a questão só matéria de direito, ou sendo de fato também, porém dispensando provas, cumpre-lhe assim o fazer, em atendimento à inteligência do § 2º, do art. 278 do CPC/1973, lido ao contrário. E, em verdade, cuida a hipótese de conflito que dispensa a realização de provas, bastando para sua solução ter em consideração a pronta aplicação dos dispositivos legais*".

II- 1) MÉRITO

O ponto nevrálgico da presente liça, repousa sobre a análise da legalidade ou não da negativa de tratamento multidisciplinar para Transtorno global do Desenvolvimento (CID 10: F84.9 e CID 11: 6A02.Z) prescrito pela neurologista pediatra, Dra. Mayllin Freitas Nunes, neurologista infantil, CRM 20766 (id 77343222).

Primeiramente, constata-se que o caso traz uma verdadeira relação de consumo entre as partes, na medida em que a promovente contratou os serviços da promovida, na conformidade dos arts. 2° e 3° da Lei 8.078/90.

Ademais, as relações jurídicas entre as operadoras de planos de assistência à saúde e os contratantes dos serviços são regidas pela Lei 9.656 /1998.

Por outro lado, para que se configure a responsabilidade civil de reparar dano causado a outrem, necessário se faz comprovar: a) ato voluntário, omissivo ou comissivo, atribuído à empresa requerida; b) existência de um dano suportado pelo promovente; c) nexo de causalidade; d) demonstração de culpa *lato sensu* atribuída à promovida.

Da análise dos autos, a parte ré não impugna que a autora seja beneficiária do plano de saúde por ela fornecido.

Com efeito, o laudo médico encartado aos autos (id 109719534), há expressa indicação médica para Terapia aquática ou natação individual por 01 (uma) hora por semana e a Terapia Alimentar com nutricionista capacitado em dificuldade e seletividade alimentar (1 hora por semana).

Sabe-se que o transtorno do espectro autista é considerado uma deficiência para todos os fins (Transtorno Global do Desenvolvimento - CID – 10 F84), conforme artigo 1º, § 2º, da Lei 12.764/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, sendo assegurado a pessoa com tal transtorno o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo o atendimento multiprofissional (artigo 3º, inciso III, alínea "b" da referida lei).

A Lei 12.764/12, que regula a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, prevê:

> *Art. 2º São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista:*
>
> *III – a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes;*

Por sua vez, a Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, traz como obrigatoriedade a cobertura das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, frequentemente designada pela sigla CID – 10, sendo o autismo, previsto como Transtorno Global do Desenvolvimento (CID – 10 F84).

É fato incontroverso que a parte autora foi diagnosticada com o autismo, devendo ser garantido a esta a assistência médica necessária vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo o atendimento multiprofissional.

No julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 0018952-81.2019.8.17.9000, o Tribunal de Justiça de Pernambuco fixou teses jurídicas sobre a obrigatoriedade dos planos de saúde a custear o tratamento multidisciplinar de pessoas com autismo abrangendo métodos e terapias especiais.

Dentre as teses fixadas, destaco:

TESE 1.0. Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários com o Transtorno do Espectro Autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico ou dentista assistente para tratar a doença ou agravo do paciente, nos termos da Resolução Normativa da ANS n. 465/2021, (com a redação dada pela Resolução da ANS n. 539/2022), inclusive em ambiente escolar e domiciliar, à luz do disposto na Lei n. 12.764/2012 art. 3°, I, III e parágrafo único.

Tese 1.1 – Os requisitos necessários para que o profissional de saúde seja considerado especialista nos métodos ABA (análise do comportamento aplicada), BOBATH, HANEN, PECS, PROMPT, TEACCH e INTEGRAÇAO SENSORIAL, de acordo com o art. 6° da Resolução Normativa da ANS n° 465/2021, deve estar conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais.

Tese 2.0 - As terapias especiais de hidroterapia, equoterapia, musicoterapia, psicopedagogia e psicomotricidade, quando aplicadas por profissionais da área de saúde, têm obrigatoriedade de cobertura pelas operadoras de planos de saúde.

Em conformidade com o art. 927, III, do CPC, deverão os juízes e os tribunais observarem os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.

Nos termos das teses 1.0 e 2.0, acima mencionadas, quanto às especialidades de fonoaudiologia, integração sensorial e psicologia, terapia aquática e psicomotricidade relacional e musicoterapia sendo tratamento ligado à recuperação neuromotora e cognitiva, há de se confirmar a permissividade e, consequentemente, a obrigatoriedade de cobertura, por se enquadrarem exatamente nas especialidades de fornecimento coagente previstas da Resolução Normativa nº 387 da ANS de 28 de outubro de 2015, em seu Anexo I, que prescreve ser coagente a: "REEDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA – REABILITAÇÃO".

Além do mais, os tratamentos prescritos para as moléstias não estão previstos no art. 10, da Lei nº 9.656/98, que enumera os procedimentos e tratamentos que poderão ser excluídos da cobertura dos planos de saúde.

No que tange ao acompanhante terapêutico escolar e domiciliar, reitere-se, o TJPE consolidou entendimento através do Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 0018952-81.2019.8.17.9000 em caráter vinculante editou a TESE 1.0.:

> ***"Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários com o Transtorno do Espectro Autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico ou dentista assistente para tratar a doença ou agravo do paciente, nos termos da Resolução Normativa da ANS n. 465/2021, (com a redação dada pela Resolução da ANS n. 539/2022), inclusive em ambiente escolar e domiciliar, à luz do disposto na Lei n. 12.764/2012 art. 3º, I, III e parágrafo único."***

Nesse diapasão, em recente informativo o TJPE ratificou o entendimento consolidado, asseverando a responsabilidade do custeio pelo plano de saúde do tratamento integral do autista, incluindo o acompanhante terapêutico escolar e domiciliar, a saber:

TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. OBSERVÂNCIA DAS TESES FIXADAS NO IAC DESTA CORTE. Julgado que apreciou a demanda de modo suficiente, com o pronunciamento acerca de todas as questões relevantes. Decisão recorrida ao determinar a cobertura integral do tratamento prescrito à parte recorrida na metodologia especializada que decidiu em harmonia com entendimento do Incidente de Assunção de Competência nº 0018952-81.2019.8.17.9000, além de observar as normas regulamentares de regência e a atual determinação da ANS. Tese do IAC, em relação ao método ABA, que expressamente consignou: "A aplicação do método ABA em ambiente escolar e domiciliar é considerada parte do tratamento de saúde da criança com TEA – Transtorno do Espectro Autista, e, portanto, a sua cobertura é obrigatória pelos planos de saúde, desde que aplicadas por profissionais da área de saúde, conforme determina o art. 6º da Resolução Normativa da ANS nº 465/2021;". Demandada que não demonstrou possuir profissionais habilitados ou clínica apta ao acompanhamento do recorrido, nos moldes das certificações exigidas para o tratamento de TEA, além de não restar evidenciada a disponibilidade de honorários para o tratamento do beneficiário. Acompanhante especializado em sala de aula que é profissional de educação, atuando junto às crianças especiais introduzidas no contexto escolar, enquanto que o acompanhante terapêutico, na condição de aplicador da ciência ABA, é profissional de saúde, integrante da equipe multiprofissional, responsável pelo acompanhamento diário do tratamento clínico/terapêutico da criança, em todos os ambientes, inclusive na escola. Obrigatoriedade de custeio integral do acompanhante terapêutico (AT) com certificado em ABA, conforme estabelecido no IAC.

(ED no AI 0000583-97.2023.8.17.9000. Relator: Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva. Julgamento: 23/01/2024).

Neste contexto, **os tratamentos de natureza médica**, **prescritos pelo médico que assiste o autor**, **nos termos da fundamentação supra**, **não podem ser excluídos**, em razão da

técnica ou método não está previsto no rol de procedimentos da ANS, visto que a ANS traz um rol meramente exemplificativo.

Deste modo, deve a seguradora autorizar/custear o tratamento das demais terapias, indicado pela médica especialista que assiste a autora, por meio de sua rede referenciada, ou ainda, por meio de profissionais de livre escolha do autor, na hipótese de inexistência de profissional dentro da rede credenciada com a aptidão específica indicada pelo médico do requerente.

Nessa hipótese, o reembolso observará a Tese 2.2 fixada no IAC 0018952-81.2019.8.17.9000, qual seja: a) será nos termos do contrato, consoante previsto no art. 12, VI, da Lei 9.656/1998, para os casos em que, mesmo havendo a prestação adequada da terapia na rede credenciada, o beneficiário optar por realizá-la na rede particular; b) será integral, no prazo de 30 (trinta) dias, quando a operadora descumpre o seu dever de garantir o atendimento, ante a indisponibilidade ou inexistência de prestador integrante da rede assistencial conveniada, nos termos do art. 9º da Resolução da ANS nº 259/2011; c) será integral, no prazo de 30 (trinta) dias, por recusa manifestamente indevida de cobertura pelo plano de saúde, o beneficiário seja obrigado a pagar os custos do atendimento.

Destaca-se, ainda que o número de consultas/sessões anuais fixado pela Agência Nacional de Saúde (ANS), na **RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 465 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021**, deve ser considerado apenas como cobertura obrigatória mínima a ser custeada plenamente pela operadora de plano de saúde, de modo que as consultas/sessões que ultrapassarem as balizas ali fixadas hão de ser suportadas também pelo usuário, em regime de coparticipação, **conforme a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça emanada por ocasião do julgamento do REsp nº 1.679.190/SP.**

Fica a parte autora cientificada que a cada quatro meses deverá apresentar laudo médico atualizado quanto à necessidade de permanência do tratamento ora deferido.

Por fim, no que pertine aos danos morais, considerando a ampliação do rol de cobertura, com a alteração do art. 6º da RN nº 465 de 2021, acrescido do § 4º, bem como comprovada a necessidade e urgência da Hidroterapia, para o tratamento de saúde do autor, portador de transtorno global do desenvolvimento, sendo negado ao autor o tratamento que lhe foi prescrito pelo médico, bem como não se constata justificativa plausível de recusa da operadora do plano de saúde, em autorizar a cobertura do necessário e imprescindível tratamento médico ao menor, de modo que resulta configurado o dever de indenizar por danos morais, diante da violação aos direitos da personalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - TRATAMENTO DE SAÚDE A MENOR - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - PORTADOR DE TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO - EQUOTERAPIA, HIDROTERAPIA E THERASUIT - NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE - DANO MORAL -DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO -Considerando a ampliação do rol de cobertura, com a alteração do art. 6º da RN nº 465 de 2021, acrescido do § 4º, bem como comprovada a necessidade e urgência dos procedimentos (Therasuit, Equoterapia e Hidroterapia) imprescindíveis para o tratamento de saúde do autor, portador de transtorno global do desenvolvimento, impõe-se a manutenção da sentença que condenou a ré a fornecer o tratamento ao autor, nos moldes prescritos no relatório médico -É inequívoco que foi negado ao autor o tratamento que lhe foi prescrito pelo médico, (...) de modo que resulta configurado o dever de indenizar por danos morais, diante da violação aos direitos da personalidade, como a dignidade e a integridade física, ultrapassando, portanto, a esfera dos meros dissabores.(TJ-MG - AC: 50540608820218130024, Relator: Des.(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 19/09/2023, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2023).

Portanto, faz-se mister a condenação da indenização por dano moral. E no caso dos autos, entendo como razoável à lesão moral a condenação do plano de saúde acionado, por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

III – DISPOSITIVO

Pelo exposto, por **SENTENÇA**, **confirmo a tutela provisória**, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e **julgo PROCEDENTE** os pedidos formulados na inicial, o que faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, *ex vi* do art. 487, inciso I, primeira parte, do Código de Processo Civil. Em consequência, **CONDENO** a demandada a autorizar/custear o tratamento médico, indicado pela médica que assiste a autora, por meio de sua rede referenciada, ou ainda, por meio de profissionais de livre escolha do autor, na hipótese de inexistência de profissional dentro da rede credenciada com a aptidão específica indicada pelo médico do requerente.

Também por **SENTENÇA**, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, julgo **PROCEDENTE em parte** os pedidos formulados na inicial, o que faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, *ex vi* do art. 487, inciso I, primeira parte, do Código de Processo Civil. Em consequência, a condenação do plano de saúde acionado, por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), incidindo juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária, conforme tabela ENCOGE/TJPE, a partir do arbitramento.

Nessa hipótese, o reembolso observará a Tese 2.2 fixada no IAC 0018952-81.2019.8.17.9000, qual seja: **a)** será nos termos do contrato, consoante previsto no art. 12, VI, da Lei 9.656/1998, para os casos em que, mesmo havendo a prestação adequada da terapia na rede credenciada, o beneficiário optar por realizá-la na rede particular; **b)** será integral, no prazo de 30 (trinta) dias, quando a operadora descumpre o seu dever de garantir o atendimento, ante a indisponibilidade ou inexistência de prestador integrante da rede assistencial conveniada, nos termos do art. 9º da Resolução da ANS nº

259/2011; **c)** será integral, no prazo de 30 (trinta) dias, por recusa manifestamente indevida de cobertura pelo plano de saúde, o beneficiário seja obrigado a pagar os custos do atendimento.

Fica a parte autora cientificada que a cada quatro meses deverá apresentar laudo médico atualizado quanto à necessidade de permanência do tratamento ora deferido.

No que diz respeito a cobertura de nutricionista capacitado em dificuldade e seletividade alimentar, encontra-se a ré desobrigada de cobertura com a referida capacidade, permanecendo a obrigação de cobertura de nutricionista, nos termos da fundamentação supra.

Por fim, considerando a sucumbência, CONDENO a demandada em custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando para estes o percentual de 10% (dez por cento) a incidir sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões (art. 1010 (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28887524/artigo-1010-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015), § 1º (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28887513/par%C3%A1grafo-1-artigo-1010-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015), do CPC/2015 (https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174788361/lei-13105-15)), e em seguida, com ou sem resposta, sigam estes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com os cumprimentos deste Juízo (art. 1010 (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28887524/artigo-1010-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015), § 3º (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28887505/par%C3%A1grafo-3-artigo-1010-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015), do CPC/2015 (https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174788361/lei-13105-15)).

Após o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo, independentemente de nova determinação.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Petrolina, data da assinatura.

CAIO SOUZA PITTA LIMA
Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: CAIO SOUZA PITTA LIMA
03/12/2024 16:14:53
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 189897010

24120316145312700000185158493

IMPRIMIR GERAR PDF